

■ 意識障害／SR・メタ解析

多感覚刺激療法で意識障害に改善 昏睡からの覚醒オッズ比9.85

18研究884人、ただし大半にバイアス懸念

獲得性脳損傷による重度の意識障害(DoC)を持つ成人を対象に、多感覚刺激療法(MST)の効果を検証したシステマティックレビュー・メタ解析。18研究・20比較・884人が対象で、通常ケアや偽刺激と比較した。

結果、MST群は意識レベルの指標が有意に改善(SMD1.48, 95%CI

1.04-1.92)。CRS-R 限定でも SMD1.23(95%CI 0.55-1.91)と有意だった。昏睡からの覚醒(coma emergence)のオッズ比は 9.85(95%CI 3.86-25.01)。

評価には RoB2 と ROBINS-Iが併用され、含まれた研究の大半でバイアスリスクの懸念が指摘された。効果の大きさを

そのまま鵜呑みにせず、標準化プロトコルでの追試が必要な段階。



18研究884人のSR・メタ解析で見た意識障害への刺激療法の効果

出典 [Disability and Rehabilitation](#) ↗

数字で見る

884人

18研究20比較の対象

1.48_{SMD}

意識レベル改善の効果量

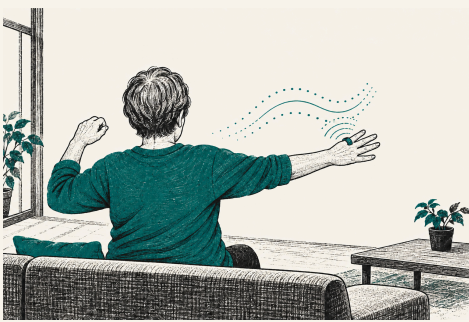
9.85_{OR}

昏睡からの覚醒オッズ比

■ 心臓リハビリ／RCT

スマートリング在宅心臓リハ ピークVO2が有意に改善

心血管疾患患者64人を、電話カウンセリング併用の介入群と運動データ記録のみの対照群に無作為割付。3か月後、介入群のほうがピーク酸素摂取量の改善幅が有意に大きかった(群間差 2.0mL/kg/min, 95%CI 0.7-3.3, P=.004)。n=32/



群と小規模で、再現性は今後の課題。

出典 [J Korean Med Sci](#) ↗

■ 摂食嚥下／更新版SR

口腔内所見は嚥下障害の手がかり 更新版システマティックレビュー

2015～2025年の15研究を採用したPRISMA準拠SR。残存歯数減少・咬合支持欠如・機能歯数低下、口腔乾燥感・唾液分泌低下、舌圧・口唇閉鎖力・頬筋力低下が嚥下障害リスクと一貫して関連。標準化スクリーニング指標の確立を提言して



いる。

出典 [Special Care in Dentistry](#) ↗

短 信

〈脳卒中／Cochrane〉心肺トレーニングSR新版

53研究2672人。死亡は不変(高確実性)、歩行・バランスは改善も不確実。 出典 [Cochrane Database Syst Rev](#) ↗

〈心不全／ベイズNMA〉HFpEF運動療法を比較

15RCT1161人。併用トレ・HIITがpeakVO2改善(SMD0.46-0.58)。 出典 [ESC Heart Fail](#) ↗

〈脳卒中／疫学〉誤嚥性肺炎死亡が四半世紀で半減

米29.6万件。AAMR9.20→3.55、非都市部は高止まり。 出典 [Brain Behav](#) ↗

〈骨粗鬆症／Cochrane〉男性の骨折予防薬を精査

50歳以上男性、ビスホスホネート等の益と害を検証。 出典 [Cochrane Database Syst Rev](#) ↗

〈COPD／NMA〉太極拳・ヨガが肺リハで上位

47RCT4720人。ヨガが運動耐容能・肺機能で最上位確率。 出典 [Front Med \(Lausanne\)](#) ↗

〈泌尿器科／RCT〉前フレイル高齢男性に術前プレハビリ

80人RCT。前立腺全摘前の短期在宅多因子介入を検証。 出典 [BMC Geriatr](#) ↗

〈がんリハ／RCT〉放射線治療中の予防的在宅運動

24人RCT。嚥下QOL・頸部可動域を有意に温存(P<.05)。 出典 [Otolaryngol Head Neck Surg](#) ↗

〈心臓リハビリ／SR〉低中所得国の心臓リハを再評価

運動主体心臓リハのRCTを対象にSR+MA。有効性・費用等を検証。 出典 [Eur J Prev Cardiol](#) ↗